EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

> Há 25 séculos, a aurora ocorreu porque a Medicina, Filosofia e Democracia interagiam entre si. No séc. XXI, temos a possibilidade de unir não apenas a Medicina, mas todas as profissões da saúde, não apenas a Filosofia, mas todas as ciências humanas e sociais, não apenas as ciências biológicas, mas toda a tecnociência e estamos empenhados na defesa e no aperfeiçoamento da democracia.
>
> WILLIAM SAAD HOSSNE

A **SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA (SBB)**, associação civil devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n. 01.690.794/0001-25 (Doc. 1), com sede à SRTV/Norte Q. 702 Conjunto P, Sala 1014, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70719-900, devidamente representada nos termos de seu Estatuto Social (Doc. 2) por sua Presidenta, Elda Bussinguer, brasileira, casada, Professora, RG 352784 SSP/ES; CPF: 578.744.097-87, residente na rua Carlos Nicoletti Madeira n.60 apt. 203, Edifício Lugano, Barro Vermelho, CEP 29057-520 Vitória/ES, e endereço eletrônico elda.cab@gmail.com (Doc. 3), vem, mui respeitosamente, por seu advogado constituído, conforme procuração anexa (Doc. 4), e com fundamento no art. 102, I, *a* e *p*, e no art. 103, IX, da Constituição Federal, e no art. 1.º e ss. da Lei n. 9.868/1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

com pedido de medida cautelar *ad referendum*

tendo por objeto a Lei nº 14.874/2024 pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1. CABIMENTO DA PRESENTE ADI E SÍNTESE DA PRETENSÃO DEDUZIDA

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade na qual se pede a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 14.874/2024, pelos seguintes fundamentos:

i. VÍCIO DE INICIATIVA FORMAL: A lei, de origem parlamentar, criou e organizou um órgão da administração pública federal ("instância nacional de ética em pesquisa" no Ministério da Saúde), o que é de iniciativa privativa do Presidente da República (Art. 61, §1º, II, "b" e "e", da CF).

ii. RETROCESSO SOCIAL E VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: As disposições da lei sobre o acesso pós-estudo (Arts. 30 a 37) estabelecem restrições significativas ao tratamento contínuo de participantes de pesquisa, configurando um retrocesso em relação ao patamar protetivo anterior (Res. CNS 466/2012) e violando o direito fundamental à saúde (Art. 6º e 196 da CF), bem como princípios de progressividade de direitos sociais previstos em tratados internacionais.

iii. ÔNUS FINANCEIRO AO SUS SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: A lei transfere para o Sistema Único de Saúde (SUS) e instituições públicas o ônus financeiro de custear tratamentos pós-estudo e indenizações (arts. 26, § 3.º e 33, VII), sem a devida estimativa de impacto orçamentário e financeiro, violando o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

iv. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA E CONSENTIMENTO INFORMADO: O art. 18, § 6.º, da lei permite a inclusão de participantes em pesquisa em situação de emergência sem consentimento prévio, o que afronta a autonomia do

paciente e o consentimento informado, contrariando a dignidade humana e a jurisprudência do STF (Tema 1.069 de RG).

v. RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL: A lei não assegura a efetiva e deliberativa participação da comunidade na governança da ética em pesquisa, esvaziando a diretriz constitucional de controle social na saúde (art. 198, III, da CF).

vi. INCOMPATIBILIDADE COM TEMAS DE REPERCUSSÃO GERAL: As restrições ao acesso pós-estudo impostas pela lei geram incompatibilidade com a racionalidade dos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral do STF, empurrando pacientes à judicialização sem garantia de tutela.

2. Conforme dispõe o art. 102, I, "a" da Constituição Federal de 1988, cabe ação direta de inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal, tal como na ação em tela, em que se faz a impugnação de dispositivos normativos da Lei 14.874/2024. Cabível, portanto, a presente ADI.

2. DA LEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA

1. A SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA é legitimada para propor a presente ação porque cumpre com os requisitos fixados pela Constituição Federal, bem como pela jurisprudência desta Corte.

2. A Constituição Federal estabeleceu que, dentre os legitimados para provocar o Supremo Tribunal Federal a exercer o controle abstrato de normas pela via

da ação direta de inconstitucionalidade encontra-se **a entidade de classe de âmbito nacional** (art. 103, inciso IX, CF c.c. art. 2.º, inciso IX, Lei n.º 9.868/1999).

3. Além do **caráter nacional** da entidade de classe, a ser comprovado pela presença de membros associados em pelo menos nove Unidades da Federação[1], a jurisprudência deste E. STF exige a comprovação da **pertinência temática** entre o objeto da ADIn e as atividades desenvolvidas pela entidade que a ajuizou.

4. Neste sentido, registra-se que a SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA possui representatividade nacional (Doc. 5), contando com membros associados espalhados por mais de nove Estados Federativos. Além disso, possui representações regionais com diretorias estaduais e autônomas nos Estados de Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Piauí e Distrito Federal.

5. Sediada em Brasília/DF (art. 1.º, parágrafo único), a Sociedade Brasileira de Bioética foi fundada de forma não oficial em 1992, na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual Paulista (UNESP), capitaneada pelo saudoso professor William Saad Hossne, que também presidiu o Grupo Especial de Trabalho indicado pelo Conselho Nacional de Saúde em 1995 para estabelecer as regras de pesquisa clínica com seres humanos, resultando na Res. CNS 196/1996.

[1] STF, ADI 6.571 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julg. 22.3.2021, DJU 26.4.2021; STF, ADI 4.230 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, JULG. 01.8.20211; DJE 14.9.2011; STF, ADI 108 QO/DF, rel. Min. Celso de Mello, julg. 13.4.1992; DJ 05.6.1992.

6. Durante os trabalhos do Conselho Nacional de Saúde para estabelecer o sistema de ética em pesquisa com seres humanos no Brasil, em 1995, é que se fundou formalmente a Sociedade Brasileira de Bioética, tendo como seu primeiro presidente o mesmo coordenador do grupo de trabalho que construiu a Res. CNS 196/1996[2].

7. A pertinência temática da Sociedade Brasileira de Bioética para questionar a constitucionalidade da Lei de Pesquisa Clínica com seres humanos decorre da sua própria história e trajetória. Neste sentido, vale citar que na primeira edição dos "Cadernos de Ética em Pesquisa" da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa consta especial reconhecimento à história da Sociedade Brasileira de Bioética com o tema:

> Criada em 1992 e implementada três anos depois, a Sociedade Brasileira de Bioética abre mão das funções executivas para investir em discussões que estão longe de soar uníssonas. Com abordagens cada vez mais próximas do dia a dia das pessoas e assuntos que geram discussões em diferentes instâncias – do aborto a engenharia genética, por exemplo –, a Bioética, como já aconteceu em Porto Alegre, Botucatu e Londrina, começa a ganhar núcleos regionais.[3]

8. Além disso, é finalidade da Sociedade Brasileira de Bioética, nos termos do art. 2.º de seu Estatuto:

---

[2] ZANELLA, Diego Carlos; GUILHEM, Dirce Bellezi. **História da Bioética no Brasil.** Curitiba: PUC-PR, 2023, p. 78.
[3] CONEP. Cadernos de ética em pesquisa, ano 1, n. 1, julho de 1998, p. 15.

> I – congregar profissionais de diferentes formações, bem como estudantes e representantes da sociedade civil, no intuito de fomentar o progresso científico, através do estudo, da ampla divulgação e da aplicação prática da Bioética;
>
> II – promover a Bioética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia, o meio ambiente, dentre outros valores universais (Lei 9.790/1999, art. 3, XI);
>
> III - desenvolver estudos e pesquisas, produzir e divulgar informações e conhecimentos técnicos e científicos (Lei 9.790/1999, art. 3, XII) relacionados à Bioética;
>
> IV – auxiliar órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como entidades públicas e privadas, em questões afeitas à Bioética;
>
> V – habilitar-se nos Tribunais Superiores como amicus curiae em casos envolvendo a Bioética;
>
> VI – promover a Bioética entre seus associados;
>
> VII– promover a difusão dos Comitês de Bioéticas em instituições de saúde;
>
> **VIII – promover medidas judiciais ou administrativas em temas envolvendo a Bioética, Saúde Pública e/ou Direitos Humanos.**

9. Consonante com tais objetivos, a SBB já atuou em diversas ações de controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que, portanto, já reconheceu a legitimidade ativa da Sociedade Brasileira de Bioética:

a) ADPF 989/DF;

b) ADPF 1.207/DF.

10. Por fim, cabe rememorar que a história da Bioética no Séc. XX está diretamente relacionada a uma reação aos abusos de pesquisas clínicas com seres humanos que tragicamente ocorreram nos mais diversos lugares do mundo, levando-se à necessidade de criar uma ponte entre os diversos

conhecimentos para questionar quais os limites éticos e jurídicos do desenvolvimento da ciência[4].

11. Indubitável, portanto, que a Sociedade Brasileira de Bioética corresponde à entidade de classe de âmbito nacional com pertinência temática para figurar como legitimada na presente ação direta de inconstitucionalidade, em especial a teor do alcance que conferiu o próprio Supremo Tribunal Federal ao art. 103, IX, da CF, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADPF 527/DF, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. À época, superou-se entendimento anteriormente adotado para conhecer da ação direta ajuizada pela Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros. Visando a estimular a abertura do controle concentrado à sociedade civil, aos grupos minoritários e vulneráveis, a Corte considerou enquanto entidade de classe para fins do disposto no art. 103, IX da CF o conjunto de pessoas ligadas por uma mesma atividade econômica, profissional ou pela defesa de interesses de grupos vulneráveis e/ou minoritários cujos membros as integrem.[5]

12. Trata-se de interpretação contemporânea, à qual, anteriormente, o próprio Ministro Presidente do STF aderiu:

> Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal 11.516/2007. Criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Legitimidade da Associação Nacional dos Servidores do Ibama. (...) A democracia participativa delineada pela Carta de 1988 se baseia na generalização e profusão das vias de participação dos cidadãos nos provimentos estatais, por isso que é de se conjurar uma exegese demasiadamente restritiva do

[4] FÜRST, Henderson. **Teoria do Biodireito**. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2023, p. 95.
[5] ABBOUD, Georges. **Processo Constitucional Brasileiro.** São Paulo: Ed. RT, 2021, p. 494

> conceito de "entidade de classe de âmbito nacional" previsto no art. 103, IX, da CRFB. **A participação da sociedade civil organizada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade deve ser estimulada, como consectário de uma sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, na percepção doutrinária de Peter Häberle, mercê de o incremento do rol dos legitimados à fiscalização abstrata das leis indicar esse novel sentimento constitucional.** In casu, a entidade proponente da ação sub judice possuir ampla gama de associados, distribuídos por todo o território nacional, e que representam a integralidade da categoria interessada, qual seja, a dos servidores públicos federais dos órgãos de proteção ao meio ambiente.
>
> (ADI 4.029, rel. min. Luiz Fux, j. 8-3-2012, P, DJE de 27-6-2012 - destacamos)

13. Por todo o exposto, considerando a atuação da Sociedade Brasileira de Bioética e a intrínseca pertinência temática ao objeto da presente ADI, bem como o atual estado da compreensão deste E. Supremo Tribunal Federal quanto à interpretação do art. 103, IX, da CF, a SBB possui legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ADI.

3. DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI N.º 14.874/2024 POR VÍCIO DE INICIATIVA

1. A Lei n.º 14.874/2024 decorre de Projeto de Lei do Senado Federal n.º 200/2015 que, posteriormente, foi substituído pelo Projeto de Lei n.º 6.007/2023, como se pode observar da própria informação constante no sítio

eletrônico do Congresso Nacional[6]. Trata-se, portanto, de lei com evidente iniciativa do Poder Legislativo.

2. Dentre as diversas disposições relacionadas à pesquisa clínica com seres humanos, a Lei n.º 14.874/2024 criou um órgão para regular, fiscalizar e controlar os aspectos éticos da pesquisa com seres humanos. Trata-se da "**instância nacional de ética em pesquisa**", definida no art. 2.º, XXVI, como:

> Art. 2.º (...)
>
> (...)
>
> XXVI - instância nacional de ética em pesquisa: colegiado interdisciplinar e independente, integrante do Ministério da Saúde, sob a coordenação da área técnica responsável pelo campo da ciência e tecnologia, de caráter normativo, consultivo, deliberativo e educativo, competente para proceder à regulação, à fiscalização e ao controle ético da pesquisa, com vistas a proteger a integridade e a dignidade dos participantes da pesquisa, e para contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos;

[6] Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/materias/materias-bicamerais/-/ver/pls-200-2015 e Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/161597

3. Além de vincular a Instância Nacional de Ética em Pesquisa ao Ministério da Saúde (art. 2.º, XXVI), a lei também determinou o rol de atribuições da atuação da Instância no art. 8.º, bem como indicou diversas atuações e responsabilidades em dispositivos dispersos ao longo da lei. A Lei também instituiu o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, do qual a Instância Nacional de Ética em Pesquisa é parte, nos termos do art. 5.º.

4. Como se pode observar, um projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo dispôs expressamente sobre a criação de órgão como "colegiado... que integra o Ministério da Saúde", com competências normativas, deliberativas e recursais (arts. 5.º e 8.º; art. 2.º, XXVI).

5. Todavia, **a Constituição Federal estabeleceu que é de competência privativa do Presidente da República a iniciativa para a propositura de leis que disponham sobre organização administrativa** (art. 61, § 1.º, II, "b") e **criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública** (art. 61, § 1.º, II, "e").

6. Fica evidente, portanto, que a Lei 14.874/2024, de iniciativa parlamentar, não observou regras de competência estabelecidas pela Constituição Federal, criando-se uma inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

7. Vale ressaltar que **o ato sancionador pelo Presidente da República não convalida o vício de iniciativa**, conforme a jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal:

> Processo legislativo e iniciativa reservada das leis — A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica,

> contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte. Precedentes. Doutrina. Nem mesmo eventual aquiescência do Chefe do Poder Executivo mediante sanção, expressa ou tácita, do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar esse defeito jurídico radical. Insubsistência da Súmula nº 5/STF (formulada sob a égide da Constituição de 1946), em virtude da superveniente promulgação da Constituição Federal de 1988. Doutrina. Precedentes
>
> (ADI 2.364, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018)

8. Neste sentido, portanto, **necessário que se declare a inconstitucionalidade da Lei 14.874/2024**, porquanto dispõe sobre organização administrativa (art. 61, § 1.º, II, "b") e criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública (art. 61, § 1.º, II, "e"), que são matérias privativas de iniciativa da Presidência da República.

4. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA REGULAÇÃO DE ACESSO PÓS-ESTUDO

1. Pacientes que são sujeitos de pesquisa são vulneráveis por diversos aspectos e a história nos ensina que, ao longo do tempo, incontáveis desrespeitos e abusos diversos foram realizados contra tais pacientes.

2. Por conta da histórica vulnerabilidade de pacientes sujeitos de pesquisa, a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos estabeleceu que

Artigo 8º - Respeito pela vulnerabilidade humana e integridade pessoal

Na aplicação e no avanço dos conhecimentos científicos, da prática médica e das tecnologias que lhes estão associadas, deve ser tomada em consideração a vulnerabilidade humana. Os indivíduos e grupos particularmente vulneráveis devem ser protegidos, e deve ser respeitada a integridade pessoal dos indivíduos em causa.

3. Participantes de pesquisa não são meros "pacientes", mas pessoas que se submetem a riscos em benefício do avanço científico e da coletividade. Essa condição impõe um dever de proteção estatal *reforçado*, que a lei fragiliza. A proteção da dignidade humana dos participantes de pesquisa, em sua condição de extrema vulnerabilidade, exige um escrutínio constitucional rigoroso das normas que mitigam direitos fundamentais.

4. A proteção à vulnerabilidade de pacientes sujeitos de pesquisa clínica deve ser, portanto, observada na análise dos mais diversos aspectos que serão demonstrados a seguir, por se tratar de um direito humano reconhecido pelo Brasil por meio de tratado internacional de direitos humanos.

5. Um dos marcos historicamente estabelecidos no sistema de ética em pesquisa com seres humanos no Brasil, desde 1996, diz respeito ao acesso a tratamento pós-estudo. Trata-se de um direito que pacientes participantes de um estudo tem de fruir do benefício gerado pelo estudo na forma de tratamento.

6. O marco normativo vigente até a Lei 14.874/2024 era a Res. CNS 466/2012, que estabelecia um patamar superior de cuidados à saúde e vulnerabilidade dos pacientes sujeitos de pesquisa, como se pode observar:

> III.3 - As pesquisas que utilizam metodologias experimentais na área biomédica, envolvendo seres humanos, além do preconizado no item III.2, deverão ainda:
>
> (...)
>
> d) assegurar a todos os participantes ao final do estudo, por parte do patrocinador, acesso gratuito e por tempo indeterminado, aos melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos que se demonstraram eficazes: d.1) o acesso também será garantido no intervalo entre o término da participação individual e o final do estudo, podendo, nesse caso, esta garantia ser dada por meio de estudo de extensão, de acordo com análise devidamente justificada do médico assistente do participante.

7. Todavia, a Lei 14.874/2024 mudou completamente a regulação jurídica do acesso pós-estudo, como se pode ver nos arts. 30 a 37:

> DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO PÓS-ENSAIO CLÍNICO
>
> Art. 30. Antes do início do ensaio clínico, o patrocinador e o pesquisador submeterão ao CEP plano de acesso pós-estudo, com apresentação e justificativa da necessidade ou não de fornecimento gratuito do medicamento experimental após o término do ensaio clínico aos participantes que dele necessitarem.
> § 1º Caso haja necessidade de fornecer o medicamento pós-ensaio clínico, deverá ser elaborado programa de fornecimento pós-estudo, nos termos de regulamento.
> § 2º O programa de fornecimento pós-estudo deverá assegurar a continuidade do acompanhamento de segurança do participante, de forma a garantir o recebimento do tratamento experimental após o término do ensaio clínico, por prazo determinado.
> § 3º O programa de fornecimento pós-estudo deverá ser iniciado somente após aprovação regulatória, cuja solicitação deve ser submetida em tempo

hábil a fim de que o participante da pesquisa faça a transição para o período pós-estudo sem prejuízo da continuidade do tratamento.

Art. 31. Ao término do ensaio clínico, deverá ser realizada, individualmente, avaliação sobre a necessidade de continuidade do tratamento experimental para cada participante.

§ 1º A avaliação a que se refere o **caput** deste artigo será realizada pelo pesquisador, ouvidos o patrocinador e o participante da pesquisa, nos termos de regulamento.

§ 2º O fornecimento gratuito pós-ensaio clínico do medicamento experimental deverá ser realizado sempre que este for considerado a melhor terapia ou tratamento para a condição clínica do participante da pesquisa e apresentar relação risco-benefício mais favorável em comparação com os demais tratamentos disponíveis.

§ 3º O fornecimento gratuito pós-ensaio clínico do medicamento experimental, quando necessário, será garantido após o término da participação individual por meio de programa de fornecimento pós-estudo, para o qual o participante deverá migrar automaticamente.

§ 4º Nos casos em que a manutenção do tratamento com medicamento experimental for necessária após o término do ensaio clínico, o fornecimento do medicamento será de responsabilidade do patrocinador.

Art. 32. A avaliação sobre a necessidade de continuidade do fornecimento do medicamento experimental pós-ensaio clínico deverá ser realizada de acordo com os seguintes critérios:

I - a gravidade da doença e sua ameaça à continuidade da vida do participante;

II - a disponibilidade de alternativas terapêuticas satisfatórias para o tratamento do participante da pesquisa, considerada sua localidade;

III - se o medicamento experimental contempla uma necessidade clínica não atendida;

IV - se a evidência de benefício para o participante supera a de risco com o uso do medicamento experimental.

Art. 33. O fornecimento gratuito do medicamento experimental no âmbito do programa de fornecimento pós-estudo poderá ser interrompido, mediante submissão de justificativa ao CEP, para apreciação, apenas em alguma das seguintes situações:

I - decisão do próprio participante da pesquisa ou, quando esse não puder expressar validamente sua vontade, pelos critérios especificados no art. 18 desta Lei;

II - cura da doença ou agravo à saúde, alvos do ensaio clínico, ou introdução de alternativa terapêutica satisfatória, fato devidamente documentado pelo pesquisador;

III - ausência de benefício do uso continuado do medicamento experimental ao participante da pesquisa, considerados a relação risco-benefício fora do contexto do ensaio clínico ou o aparecimento de novas evidências de riscos relativos ao perfil de segurança do medicamento experimental, fato devidamente documentado pelo pesquisador;

IV - ocorrência de reação adversa que, a critério do pesquisador, inviabilize a continuidade do medicamento experimental, mesmo diante de eventuais benefícios;

V - impossibilidade de obtenção ou de fabricação do medicamento experimental por questões técnicas ou de segurança, devidamente justificadas, e desde que o patrocinador forneça alternativa terapêutica equivalente ou superior existente no mercado;
VI - (VETADO);
VI - transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da disponibilidade comercial do medicamento experimental no País; (Promulgação partes vetadas)
VII - disponibilidade do medicamento experimental na rede pública de saúde.
Art. 34. O pesquisador será responsável por solicitar ao patrocinador o início do fornecimento pós-ensaio clínico do medicamento experimental ao participante da pesquisa, conforme critérios definidos nesta Lei.
§ 1º O patrocinador garantirá aos participantes da pesquisa o fornecimento gratuito pós-ensaio clínico do medicamento experimental sempre que este for considerado pelo pesquisador como a melhor terapêutica para a condição clínica do participante da pesquisa e apresentar relação risco-benefício mais favorável em comparação com os demais tratamentos disponíveis, nos termos desta Lei e de regulamento.
§ 2º O fornecimento gratuito pós-estudo do medicamento experimental de que trata o § 1º deste artigo será garantido após o término da participação individual, por meio de programa de acesso pós-estudo, e o participante deverá migrar automaticamente para esse novo protocolo.
§ 3º Para atender ao disposto neste artigo, a importação e a dispensação de medicamento experimental durante o programa de acesso pós-estudo deverão ser previamente autorizadas pela autoridade sanitária competente, nos termos de regulamento.
Art. 35. O pesquisador, o patrocinador e a instituição na qual houver ocorrido a pesquisa deverão fazer planos de transição dos participantes que continuarem a necessitar de cuidados ou medidas de saúde, após o término do ensaio clínico, para os serviços de saúde adequados, conforme disponibilidade, nos termos desta Lei, desde que tais cuidados não sejam relacionados a reações advindas do próprio estudo.
§ 1º Deverá ser considerada também a transição planejada dos participantes que tenham recebido o fornecimento gratuito de medicamento ou tratamento pós-ensaio clínico para outros meios de fornecimento disponíveis, caso necessário.
§ 2º No caso de reações advindas do próprio estudo, o patrocinador deverá garantir os cuidados ou as medidas de saúde adequados e necessários para o participante da pesquisa.
Art. 36. O uso de medicamento experimental durante programa de fornecimento pós-estudo obedecerá às normas estabelecidas em regulamento.
Art. 37. Aplicar-se-ão aos produtos e dispositivos médicos e aos produtos de terapias avançadas experimentais, objeto de ensaio clínico, as disposições deste Capítulo, no que couber.

8. A Lei 14.874/2024, ao dispor do acesso pós-estudo, criou diversos empecilhos para que um paciente que foi sujeito de pesquisa clínica consiga a continuidade de seu tratamento, e o faz criando diversas inconstitucionalidades, como (i) o retrocesso a direitos fundamentais; (ii) violação do direito fundamental à saúde; (iii) criação de custos ao orçamento público; (iv) incompatibilidade com o Tema de Repercussão Geral n.º 1.234.

9. Como são diversos fenômenos com elementos distintos de inconstitucionalidade, passaremos a cuidá-los separadamente.

4.1 DA INCONSTITUCIONALIDADE POR RETROCESSO A DIREITOS FUNDAMENTAIS

1. Se, até a Lei 14.874/2024, pacientes sujeitos de pesquisa no Brasil tinham assegurado o acesso ao benefício produzido pela pesquisa como um direito, esse direito sofreu diversas restrições com a Lei 14.874/2024, como se pode perceber pela leitura dos arts. 30 a 37. As restrições vão desde custeio, tempo de acesso, a interrupções por motivos diversos.

2. Tais restrições comprovam que há evidente retrocesso da nova lei em relação ao patamar de direitos anteriores a ela, e disso decorre sua inconstitucionalidade por retrocesso a direitos fundamentais, uma vez que o acesso pós-estudo impacta diretamente no direito fundamental à saúde de pacientes sujeito de pesquisa.

3. A vedação ao retrocesso de direitos fundamentais é um direito fundamental implícito que foi expressamente incorporado pelo Brasil por ocasião da

assinatura do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, incorporado ao ordenamento brasileiro pelo Decreto n.º 591/1992, que expressamente estabeleceu:

> Artigo 2º, § 1.º: Cada Estado Membro no presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas.
>
> (...)
>
> Artigo 11, § 1.º: Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida.(...).

4. A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), que foi incorporada pelo Decreto n.º 678/1992, estabeleceu o desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e culturais:

> Artigo 26. Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, tanto no âmbito interno, como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de

> Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados.

5. A Convenção Americana teve um Protocolo Adicional, o Protocolo de San Salvador, de 1988 (incorporado pelo Decreto n.º 3.21/1999), que também reconheceu a progressividade dos direitos humanos em seu Artigo 1.º:

> Os Estados-Partes neste Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos comprometem-se a adotar as medidas necessárias, tanto de ordem interna como por meio da cooperação entre os Estados, especialmente econômica e técnica, até o máximo dos recursos disponíveis e levando em conta seu grau de desenvolvimento, a fim de conseguir, progressivamente e de acordo com a legislação interna, a plena efetividade dos direitos reconhecidos neste Protocolo .

6. Nota-se, portanto, que o Brasil pactuou um por tratados internacionais de direitos humanos um *dever de progressividade dos direitos sociais*. Uma vez que se efetive um direito, não é possível retornar ao patamar anterior. Por conta de tal compreensão é que também se chama o direito em questão como *efeito cliquet* ou *cliquet anti-retour*[7], em alusão ao instrumento de segurança utilizado por atletas de escalagem para evitar que, em alguma queda, retroceda a um patamar anterior ao do mecanismo de trava. Esta compreensão decorre diretamente dos pactos internacionais de direitos humanos, que apresentamos anteriormente. Na doutrina, se dá pela compreensão de que, sendo o Estado Social de Direito

[7] MOLLION, Grégory. Les garanties légales des exigences constitutionnelles. **Revue française de droit constitutionnel**, n. 62, v. 2, p. 232, 2005.

aquela modalidade desenvolvida historicamente para conduzir e garantir a máxima efetividade de direitos sociais, estaria também implícita a proibição de retroceder, sem que houvesse uma própria falência do modelo de Estado[8].

7. Também no âmbito da jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal se verifica o reconhecimento e aplicação da vedação ao retrocesso de direitos fundamentais, tendo sua primeira aplicação em 2000, por meio da ADI 2.065/DF[9].

8. No âmbito da saúde, a vedação de retrocesso também foi reconhecida pelo STF por ocasião do ARE n.º 727.864/PR, julgado em 4.11.2014. Naquela ocasião, manifestou-se o Ministro relator que:

> Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive, consoante adverte autorizado magistério doutrinário [...].Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, verdadeira dimensão negativa pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (como o direito à saúde), impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese –de todo inocorrente na espécie –em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais[10]

[8] SARLET, Ingo. Notas sobre a assim designada proibição de retrocesso social no constitucionalismo latino-americano. **Revista do TST**. Brasília, vol. 75, n. 3, pp. 116-149 (p. 117).
[9] Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2.065/DF. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Brasília: STF, 2000.
[10] Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo –ARE 727.864/PR. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília: STF, 2014

9. Considerando a tradição deste E. Supremo Tribunal Federal à proteção contra o retrocesso a direitos fundamentais, também no presente caso devem ser declarados inconstitucionais os arts. 30 a 37 da Lei 14.874/2024 por promoverem retrocesso ao direito fundamental da saúde de pacientes sujeitos de pesquisa no acesso pós-estudo.

10. Como também implica em riscos à saúde de pacientes sujeitos de pesquisa, passa-se a expor especificamente acerca de tal violação no próximo tópico.

4.2 DA VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE

1. A Constituição Federal e a jurisdição constitucional deste E. Supremo Tribunal Federal têm consolidado a faceta do movimento sanitarista em sua constituinte, estabelecendo não apenas o direito fundamental à saúde, como também os mecanismos de exercício de tal direito, superando a restrita compreensão de norma de eficácia contida para revolucionar a efetividade da saúde brasileira por meio de mecanismos de aplicação imediata.[11]

2. Dentre os vários conteúdos que se extraem do direito fundamental à saúde, está o do acesso ao tratamento medicamentoso, que tem se consolidado no Brasil desde os anos 2000, com especial racionalidade atribuída por este E. Supremo Tribunal Federal por meio da STA 175 e, mais recentemente, pelo Tema de Repercussão Geral n.º 1.234.

[11] FÜRST, Henderson. **Jurisdição constitucional sanitarista**. Prelo.

3. Ao se regular o acesso pós-estudo, está-se regulando diretamente o acesso ao tratamento medicamentoso, pois se trata de pesquisa cuja eficácia tenha sido comprovada e pode-se obter o registro da Anvisa para a sua disponibilização aos pacientes no Brasil.

4. A Lei 14.874/2024 é inconstitucional ao restringir o acesso medicamentoso de pacientes que tenham sido sujeitos da pesquisa que tenha originado o medicamento em questão e que estejam ainda em tratamento.

4.1 O art. 33, VI, estabelece expressa restrição com o "transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da disponibilidade comercial do medicamento experimental no País". Ocorre que entre o término da pesquisa e a disponibilidade comercial do medicamento existe uma lacuna que é relevante a tratamentos contínuos e pode implicar em graves riscos à saúde de pacientes.

4.2 Igualmente, a disponibilidade no mercado nacional não significa que o medicamento estará incorporado à política pública do SUS dentro do prazo de 5 anos para que esteja disponibilizado ao paciente que foi sujeito de pesquisa. Aliás, sequer significa que o medicamento será incorporado, em qualquer prazo que seja.

5. Percebe-se, portanto, que a regulação do acesso pós-estudo implica em lacunas de fornecimento que potencialmente resultarão em interrupção de tratamentos que pacientes sujeitos de pesquisa estejam fazendo, representando tanto um retrocesso ao parâmetro normativo atual quanto uma violação ao direito fundamental à saúde que esteja manifesto na forma de tratamento medicamentoso.

6. Outros motivos de interrupção de acesso também representam retrocesso ou incerteza jurídica.

6.1 O fundamento que consta no art. 33, V, estabelece a "impossibilidade de obtenção ou de fabricação do medicamento experimental por questões técnicas ou de segurança, devidamente justificadas, e desde que o patrocinador forneça alternativa terapêutica equivalente ou superior existente no mercado".

6.2 Ocorre que se trata de critério jurídico incerto, em que é facilmente possível alegar fundamentos que não correspondam aos interesses de proteção de pacientes, possibilitando que se realize pesquisa no Brasil, seguindo-se de interrupção do acesso a tratamento por motivo de "impossibilidade de fabricação", e sendo disponibilizado o medicamento a mercados internacionais.

6.3 Fica evidente a proteção insuficiente da vulnerabilidade de pacientes sujeitos de pesquisa no Brasil. A lei dá espaço para a discricionariedade abusiva valendo-se de fundamentos incertos justificar a realização da pesquisa no Brasil seguida da descontinuação do acesso ao tratamento desenvolvido.

7. Também o critério estabelecido no art. 33, IV, representa retrocesso e violação ao direito fundamental à saúde de pacientes ao estabelecer como critério a "ocorrência de reação adversa que, a critério do pesquisador, inviabilize a continuidade do medicamento experimental, mesmo diante de eventuais benefícios".

7.1 Na hipótese em questão, não se considera o binômio risco-benefício, de modo que o paciente que tenha obtido eventual benefício poderá deixar de ter acesso ao tratamento por algum efeito colateral tolerável.

7.2 A inconstitucionalidade é ainda mais grave quando se observa a aplicação do inciso IV a pacientes com doenças raras, ultrarraras, ou ainda crônicas sem cuidados efetivos. Qualquer benefício que tais pacientes obtenham de um tratamento representará uma grande conquista de qualidade de vida, mas que pode subitamente ser descontinuada pela discricionariedade do pesquisador, independentemente do binômio risco-benefício.

8. Com isso, verifica-se que o programa normativo estabelecido pela Lei 14.874/2024 representa tanto um retrocesso ao paradigma normativo anterior, quanto uma violação ao direito fundamental à saúde de pacientes sujeitos de pesquisa em que tal direito se manifeste por meio do acesso ao tratamento medicamentoso, pois o novo programa normativo não possibilita pleno acesso ininterrupto ao tratamento medicamentoso, e será necessário recorrer à judicialização para socorrer à violação.

9. No âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, também há violação. A Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, assinada pelo Brasil, vai no sentido oposto, determinando como um direito humano o compartilhamento de benefícios:

> **Artigo 15 – Compartilhamento de Benefícios**
>
> a) Os benefícios resultantes de qualquer pesquisa científica e suas aplicações devem ser compartilhados com a sociedade como um todo e, no âmbito da comunidade internacional, em especial com países em desenvolvimento. Para dar efeito a esse princípio, os benefícios podem assumir quaisquer das seguintes formas:
>
> **(i) ajuda especial e sustentável e reconhecimento aos indivíduos e grupos que tenham participado de uma pesquisa;**

> (ii) acesso a cuidados de saúde de qualidade;
>
> (iii) oferta de novas modalidades diagnósticas e terapêuticas ou de produtos resultantes da pesquisa;
>
> (iv) apoio a serviços de saúde;
>
> (v) acesso ao conhecimento científico e tecnológico; facilidades para geração de capacidade em pesquisa; e outras formas de benefício coerentes com os princípios dispostos na presente Declaração.
>
> (...)
>
> (grifamos)

10. Assim, além da violação ao direito fundamental à saúde, há evidente violação à Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos.

11. Vale ressaltar que tal compreensão não contraria o preceito da "Constituição Científica"[12], que estabelece o desenvolvimento do conhecimento científico como um preceito fundamental - como se observa ao proteger o trabalho intelectual que propicia o desenvolvimento científico (arts. 218 a 219-B da CF), além de estabelecer que as criações científicas integram o patrimônio cultural brasileiro (art. 216, III, da CF), deixando como competência comum da União, dos estados, DF e municípios proporcionarem os meios de acesso à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação (art. 23, V, da CF).

[12] Cf. TAVARES, André Ramos. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Saraiva, 2024, capítulo XXXIV, tópico 3; Cf., também, TOURINHO LEAL, Saul. Da Revolta da Vacina à cloroquina: a Constituição Científica. **Conjur**. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-set-23/observatorio-constitucional-revolta-vacina-cloroquina-constituicao-cientifica/

12. Na verdade, trata-se de compatibilizar o desenvolvimento científico com os mandamentos de proteção e promoção à saúde, especialmente de população hipervulnerável que são os pacientes sujeitos de pesquisa clínica.

13. E não se pode considerar o argumento de que a inexistência de uma restrição ao acesso pós-estudos implica em um impedimento à pesquisa clínica no Brasil. Nas últimas 3 décadas em que se estabeleceu o pleno acesso pós-estudo, por meio das Resoluções CNS 196/1996 e 466/2012, pesquisas clínicas foram realizadas no Brasil com êxito e lucratividade aos setores envolvidos.

4.3 DA INCONSTITUCIONALIDADE POR CRIAÇÃO DE CUSTOS AO SUS SEM ESTIMATIVA DO SEU IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO (ART. 113 DA ADCT)

1. A restrição de acesso ao tratamento pós-estudo também tem como critério a "disponibilidade do medicamento experimental na rede pública de saúde", conforme art. 33, VII, da Lei 14.874/2024.

2. O programa normativo anterior estabelecia que, mesmo que o medicamento tenha sido incorporado, o tratamento de sujeitos de pesquisa é ônus do patrocinador do estudo. Tratava-se de mecanismo de justiça social sanitarista, que deixou de ser aplicada pelo novo programa normativo.

3. Com isso, o novo programa normativo estabelecido pelo art. 33, VII, da Lei 14.874/2024, cria um ônus financeiro ao Sistema Único de Saúde: o de custear o tratamento a pacientes sujeitos de pesquisa clínica pós-estudo que, até então, era inexistente.

4. Muito embora o Tema de Repercussão Geral n.º 917 tenha estabelecido a tese de que "não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1.º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)", o presente caso é bastante distinto.

4.1 Primeiro, porque **a Lei 14.874/2024**, como já se demonstrou, **usurpou competência privativa de Chefe do Poder Executivo e tratou da estrutura do Poder Executivo**.

4.2 Segundo, porque o art. 113 da ADCT estabeleceu que "a proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro", e não consta nenhuma análise de estimativa de impacto orçamentário na proposição legislativa da Lei 14.874/2024.

5. Assim, mesmo que superado o argumento do item 4.1, entendendo-se aplicável ao presente caso o tema 917 de Repercussão Geral, há claro descumprimento do requisito estabelecido pelo art. 113 da ADCT.

6. Igual violação existe no art. 26, § 3.º, que estabelece que "As instituições e as organizações envolvidas nas pesquisas serão corresponsáveis pela sua condução e proporcionarão assistência integral aos participantes no que se refere às complicações e aos danos decorrentes da pesquisa".

7. Neste sentido, quando a pesquisa for realizada em um hospital, universidade, ou qualquer outra instituição pública, há potencial ônus orçamentário aos cofres públicos, pois serão responsáveis financeiramente pela indenização

decorrente de pesquisa financiada pela iniciativa privada. E, tal como no caso do art. 33, VII, não houve estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro quando de sua proposição legislativa.

4.4 DA INCONSTITUCIONALIDADE POR INCOMPATIBILIDADE COM OS TEMAS 6 E 1.234 DE REPERCUSSÃO GERAL

1. Fenômeno único dentre as experiências jurídicas conhecidas nesta quadra da história, a judicialização da saúde no Brasil representa um desafio não apenas ao Poder Judiciário – que precisa dialogar com conhecimentos não jurídicos, como os métodos de Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS) e os de saúde baseada em evidências (SBE) – como também ao próprio Sistema de Saúde, com interferências não planejadas na organização de recursos escassos, impactos orçamentários excessivos, dentre outras tantas consequências[13].

2. Para atribuir maior racionalidade à judicialização da saúde pública no Brasil, o STF estabeleceu os temas de repercussão geral n.º 6 e 1.234 que preveem as condições em que o Poder Judiciário poderá determinar a o fornecimento de medicamentos não incorporados.

3. Quando a Lei 14.874/2024 estabelece restrição ao acesso medicamentoso pós-estudo, cria uma demanda de acesso do medicamento ao SUS que não corresponde automaticamente à disponibilidade – é possível que um novo tratamento sequer venha a ser incorporado.

[13] FÜRST, Henderson. Acordos em jurisdição constitucional sanitarista. In: ABBOUD, Georges; NAVARRO, Trícia. **Consensualidade no STF**. São Paulo: Ed. RT, 2025.

4. Com isso, pacientes estarão ainda mais vulnerabilizados, sem poder ter acesso ao tratamento pelo SUS, vendo-se compelidos à judicialização, num retrocesso ao marco estabelecido pelos temas 6 e 1.234 de repercussão geral, e ainda estarão impossibilitados de obter pela via judicial, uma vez que esbarrarão nas condições estabelecidas nos temas.

5. DA INCONSTITUCIONALIDADE POR RESTRIÇÃO À AUTONOMIA DE PACIENTES SUJEITOS DE PESQUISA

1. Este E. Supremo Tribunal Federal promoveu um grande avanço ao direito de pacientes ao reconhecer que a autonomia para consentir (ou não) com um procedimento ou tratamento é um direito fundamental, que decorre da dignidade humana, tal como também estabelecido pela Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos em seus artigos 5 e 6:

> **Artigo 5.º Autonomia e responsabilidade individual**
>
> A autonomia das pessoas no que respeita à tomada de decisões, desde que assumam a respectiva responsabilidade e respeitem a autonomia dos outros, deve ser respeitada. No caso das pessoas incapazes de exercer a sua autonomia, devem ser tomadas medidas especiais para proteger os seus direitos e interesses.
>
> **Artigo 6.º Consentimento**
>
> 1.Qualquer intervenção médica de carácter preventivo, diagnóstico ou terapêutico só deve ser realizada com o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa em causa, com base em informação adequada.

> Quando apropriado, o consentimento deve ser expresso e a pessoa em causa pode retirá-lo a qualquer momento e por qualquer razão, sem que daí resulte para ela qualquer desvantagem ou prejuízo.
>
> 2. Só devem ser realizadas pesquisas científicas com o consentimento prévio, livre e esclarecido da pessoa em causa. A informação deve ser suficiente, fornecida em moldes compreensíveis e incluir as modalidades de retirada do consentimento. A pessoa em causa pode retirar o seu consentimento a qualquer momento e por qualquer razão, sem que daí resulte para ela qualquer desvantagem ou prejuízo. Excepções a este princípio só devem ser feitas de acordo com as normas éticas e jurídicas adoptadas pelos Estados e devem ser compatíveis com os princípios e disposições enunciados na presente Declaração, nomeadamente no artigo 27ª, e com o direito internacional relativo aos direitos humanos.
>
> 3.Nos casos relativos a investigações realizadas sobre um grupo de pessoas ou uma comunidade, pode também ser necessário solicitar o acordo dos representantes legais do grupo ou da comunidade em causa. Em nenhum caso deve o acordo coletivo ou o consentimento de um dirigente da comunidade ou de qualquer outra autoridade substituir-se ao consentimento esclarecido do indivíduo.

2. Neste sentido, é relevante fazer especial referência à tese estabelecida pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n.º 1.069:

> "1. É permitido ao paciente no gozo pleno da sua capacidade civil recusar-se a se submeter a tratamento de saúde por motivos religiosos. A recusa a tratamento de saúde por razões religiosas é condicionada à decisão inequívoca, livre, informada e esclarecida do paciente, inclusive quando veiculada por meio de diretiva antecipada de vontade. (...)".

3. Muito embora este E. Supremo Tribunal Federal tenha consolidado tal interpretação decorrente da Constituição Federal, a Lei 14.874/2024 vai na contramão, pois em seu art. 18, § 6.º, estabeleceu a possibilidade de que alguém seja incluso em pesquisa quando em situação de emergência **sem o seu consentimento**. Diz o texto:

> Art. 18. (...)
>
> (...)
>
> § 6º A inclusão de participante em pesquisa em situação de emergência e sem o seu consentimento prévio seguirá o disposto no protocolo aprovado, devendo-se, na primeira oportunidade possível, informar o fato ao participante da pesquisa ou a seu representante legal e coletar a decisão quanto à sua permanência na pesquisa.

4. Fica evidente o conflito do texto normativo à compreensão contemporânea dada por este E. Supremo Tribunal Federal, pois restringe a autonomia de pacientes em situação de profunda vulnerabilidade.

5. Vale ressaltar, inclusive, que por tal texto normativo seria possível justificar submeter pacientes que sejam submetidos à procedimentos contrários às suas convicções, e somente quando conscientes é que seriam consultados a respeito de tal procedimentos.

6. Assim, o art. 18, § 6.º, da Lei 14.874/2024 é contrário ao entendimento estabelecido por este E. Supremo Tribunal Federal nos temas de repercussão geral n.º1.069 e 952, bem como violar a dignidade humana (art. 1.º, III, da CF), direitos fundamentais à integridade física, psíquica e liberdade individual (art.

5.º, *caput*, II e III, da CF), bem como direito fundamental à proteção da saúde (arts. 196, 199, § 4.º, da CF), bem como Declaração Universal de Bioética e Direitos Humano, artigos 5 e 6.

7. Alternativamente, pede-se a interpretação conforme o Artigo 7.º da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que traz regulação específica acerca das pessoas incapazes de exprimir seu consentimento, representando uma camada maior de proteção à vulnerabilidade.

6. DA INCONSTITUCIONALIDADE POR RESTRIÇÃO À PARTICIPAÇÃO SOCIAL

1. No constitucionalismo brasileiro, a participação social na Saúde se dá pela própria origem da reforma sanitária brasileira[14], que estabeleceu uma verdadeira **democracia sanitária** no Brasil.

2. O conceito de democracia sanitária opõe-se à visão estadocêntrica e tecnocrata de sistema de saúde, que estabelecem uma via unilateral de dizer o que é saúde, tratamentos e quais direitos os pacientes possuem neste sistema; dessa forma, uma democracia sanitária pressupõe a participação, em graus e

[14] "a reforma sanitária deve ser entendida como um longo processo político de conquistas da sociedade em direção à democratização da saúde, num movimento de construção de um novo Sistema Nacional de Saúde [tendo como pressupostos]: a) visão da saúde como um processo resultante das condições de vida; b) atenção à saúde não restrita a assistência médica, envolvendo 'todas as ações de promoção, proteção e recuperação'; c) inscrição constitucional da saúde como direito de todos e dever do Estado, de modo que as ações e serviços de saúde estariam 'subordinados ao interesse público'; d) acesso universal e igualitário de toda a população a todas as ações e serviços necessários, sem discriminações; constituição do SUS com comando único em cada esfera de governo; e) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; f) distritalização; g) gestão colegiada."
PROPOSTA DA 8.ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDEª. Brasília, 1987, p. 3-5.

intensidades distintas, da sociedade civil organizada e cidadãos para a criação e tomada de decisões de políticas públicas de saúde (ainda que setorizadas, como no caso da saúde suplementar), promovendo a figura do cidadão administrado.

3. A democracia sanitária também se opõe à captação regulatória de classes profissionais de saúde, afirmando o direito de pacientes e seus familiares e cuidadores em expressar opinião e compreensão de situações sanitárias que lhes digam respeito[15].

4. A relevância da participação social decorre da própria caracterização da democracia sanitária, pois não se pode falar em democracia sanitária sem participação social. Esta é uma clara característica estabelecida pela Constituição Federal de 1988, quando determinou que uma das características das ações e serviços públicos de saúde que compõem o SUS é a da participação da comunidade, nos termos do art. 198, III, da CF.

5. No programa normativo anterior à Lei 14.874/2024, a Res. CNS 466/2012 expressamente possibilitava a participação da comunidade, e isso é facilmente observável pelas próprias atribuições da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP):

> IX – DA COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA (CONEP) ATRIBUIÇÕES:

[15] "Democracia sanitária é o regime de governo do povo, aplicado aos temas relacionados à saúde individual e coletiva, por meio do qual os cidadãos participam e influem ativamente, de forma deliberativa ou consultiva, nos processos de tomada de decisões estatais de saúde de competência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário". AITH, Fernando. **Direito à Saúde e Democracia Sanitária**. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 86.

> IX.1 - examinar os aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos, como também a adequação e atualização das normas atinentes, **podendo, para tanto, consultar a sociedade**, sempre que julgar necessário;
>
> IX.2 - **estimular a participação popular nas iniciativas de Controle Social** das Pesquisas com Seres Humanos, além da criação de CEP institucionais e de outras instâncias, sempre que tal criação possa significar o fortalecimento da proteção de participantes de pesquisa no Brasil;
>
> (...)
>
> (grifamos)

6. Tal concepção se encontrava desde a formulação do Sistema de Ética em Pesquisa Brasileiro em 1995 e 1996, quando mais de 30 mil pessoas ou entidades que poderiam contribuir com a construção do sistema de ética em pesquisa foram convidadas a participar e ativamente seguir contribuindo e participando. Tais esforços foram para criar "um sistema de controle social na boa acepção da palavra", como avaliou o professor William Saad Hossne em entrevista à Revista FAPESP[16].

7. **A Lei 14.874/2024, por sua vez, caminha no sentido oposto.**

8. Quando se observa a Instância Nacional de Ética em Pesquisa, não há qualquer determinação pela Lei 14.874/2024 de que se observar a determinação do art. 198, III, da Constituição Federal.

9. A única previsão da Lei consta no art. 7.º, VII, que estabelece:

[16] William Saad Hossne: O guardão da bioética. Revista FAPES. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/william-saad-hossne-o-guardiao-da-bioetica/

> Art. 7º A análise ética da pesquisa com seres humanos será feita conforme definido nesta Lei e de acordo com as seguintes diretrizes:
>
> (...)
>
> VII - controle social, com a participação de representante dos participantes da pesquisa;
>
> (...)

10. Tal dispositivo não efetiva o Controle Social estabelecido pelo art. 198, III, da Constituição Federal, pois somente no momento da análise de uma pesquisa é que se oportuniza parcialmente o controle social, que se dá pela participação de representante dos participantes de pesquisa.

11. Por outro lado, a Lei 14.874/2024 não viabiliza o Controle Social em outros aspectos do Sistema de Ética em Pesquisa, como a criação das regras de ética em pesquisa, a fiscalização, o acompanhamento, dentre outros elementos que compõem um sistema de ética em pesquisa, bem como do desenvolvimento da própria pesquisa clínica com seres humanos.

12. Com isso, tem-se que é inconstitucional a Lei 14.874/2024 pela inobservância do dever de Controle Social estabelecido pelo art. 198, III, da Constituição Federal, sendo insuficiente a previsão contida no art. 7.º, VII, da Lei 14.874/2024.

7. DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR *AD REFERENDUM* (ART. 10 DA LEI 9.868/1999)

1. O art. 10 da Lei 9.868/1999 prevê a possibilidade de concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.

2. A rigor, "os requisitos são os mesmos exigidos para toda e qualquer ação cautelar, notadamente o *fumus boni juris* e o *periculum in mora*. A aparência do direito se verifica quando a inconstitucionalidade é demonstrada prima facie, ainda que de forma superficial, mediante cognição sumária do STF. O perigo na demora caracteriza-se quando o autor da ADIn demonstrar que a demora no julgamento do mérito pode trazer consequências danosas para a ordem pública, razão pela qual a cautelar tem de ser concedida"[17].

3. O *fumus boni iuris* decorre da violação direta à Constituição Federal efetuada pelos diversos dispositivos indicados, em especial na usurpação de competência privativa do Chefe do Poder Executivo **(art. 61, § 1.º, *a* e *e*, da CF)**, vedação de retrocesso a direitos fundamentais, violação do direito fundamental à saúde **(arts. 6.º e 196 e ss. da CF)**, violação à diretriz de controle social **(art. 198, III, da CF)**, e onerosidade orçamentária do SUS sem análise ou estimativa de impacto orçamentário na proposição legislativa **(art. 113 da ADCT)**.

4. Como a Lei 14.874/2024 já se encontra vigente, produzindo efeitos concretos às mais diversas pesquisas que são realizadas com seres humanos no

[17] ABBOUD, Georges. Processo Constitucional Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, p. 573.

Brasil, há flagrante *periculum in mora.* E é incontornável e de magnitude elevada, dado o risco iminente de:

a) **Lesão à estrutura administrativa:** A manutenção do art. 8.º e do art. 2.º, XXVI, da Lei 14.874/2024, que cria a Instância Nacional de Ética em Pesquisa como órgão do Ministério da Saúde por iniciativa parlamentar, consolida um vício de origem que afeta a própria arquitetura institucional da administração pública federal, gerando insegurança jurídica.

b) **Dano irreversível à saúde e autonomia de pacientes sujeitos de pesquisa:** A aplicação dos arts. 30 a 37 da Lei 14.874/2024, com suas restrições ao acesso pós-estudo, implica na interrupção de tratamentos eficazes, na imposição de obstáculos indevidos e na potencial violação do direito à saúde de indivíduos em condição de vulnerabilidade, que já contribuíram com o avanço científico, podendo gerar sequelas permanentes ou agravamento de condições de saúde.

c) **Prejuízo financeiro e desorganização do SUS:** A regra do art. 33, VII, da Lei 14.874/2024, ao transferir para o SUS o ônus de custear o tratamento pós-estudo em certas condições, sem prévia estimativa de impacto orçamentário e financeiro (art. 113 do ADCT), pode gerar um desequilíbrio fiscal e comprometer a oferta de serviços essenciais à coletividade.

d) **Enfraquecimento da participação social:** A insuficiência do controle social previsto no art. 7.º, VII, da Lei 14.874/2024, bem como a inexistência de tal previsão na Instância Nacional de Ética em Pesquisa, em contraste com o modelo anterior de participação comunitária

deliberativa, representa um risco de captura regulatória e de decisões éticas que não reflitam o interesse público e a proteção dos participantes de pesquisa.

5. A demora na suspensão da eficácia ou na interpretação conforme dos dispositivos impugnados causará danos de difícil ou impossível reparação, afetando direitos fundamentais e princípios estruturantes do Estado de Direito e do sistema de saúde brasileiro.

6. Por outro lado, o programa normativo que foi revogado implicitamente pela Lei 14.874/2024, ao ser repristinado, estabelecerá os patamares normativos já conhecidos tanto pela comunidade científica, quanto por patrocinadores de pesquisas, bem como pacientes e comunidade, viabilizando a continuidade da pesquisa com seres humanos no Brasil enquanto tramita a presente ADI.

7. Diante do exposto, requer-se a concessão de medida cautelar, *ad referendum* do Plenário, nos termos que passa a pedir.

8. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, e após a concessão e ratificação da medida cautelar, a **SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA** requer a Vossa Excelência:

1. Medida cautelar (*ad referendum* do Plenário, art. 10 da Lei 9.868/1999) para:

   a. a suspensão imediata da eficácia do art. 2.º, XXVI, e do art. 8.º da Lei 14.874/2024, por vício de iniciativa (art. 61, § 1.º, II, "b" e "e", CF) ou, alternativamente, determinar liminarmente a interpretação conforme a Constituição, observando-se o art. 198, III, da CF;

b. a suspensão imediata da eficácia dos arts. 30 a 37 da Lei 14.874/2024 (continuidade do tratamento pós-ensaio), especialmente do art. 33, incisos IV, V, VI e VII, com efeito repristinatório do regime anterior do Sistema CEP/CONEP (Res. CNS n.º 466/2012 e atos correlatos), até o julgamento de mérito;

c. fixar, liminarmente, interpretação conforme à Constituição ao art. 7.º, VII, para que a aplicação da Lei 14.874/2024 observe o art. 198, III, da CF, assegurando participação social efetiva e deliberativa na governança da ética em pesquisa, com protagonismo do CNS e da CONEP na formulação normativa e na fiscalização.

d. Suspender a eficácia do art. 18, § 6.º, da Lei 14.874/2024, por violação imediata à autonomia e ao consentimento informado (Tema 1.069 da RG e arts. 1.º, III; 5.º, *caput*, II e III; e 196 da CF; Artigos 5 e 6 da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos).

e. Suspender, no que couber, a eficácia do art. 26, § 3.º, da Lei 14.874/2024, quando importar transferência de custos indenizatórios para instituições públicas sem estimativa de impacto orçamentário (art. 113 do ADCT) e sem que sejam patrocinadoras do estudo; ou, subsidiariamente, conferir interpretação conforme para que a responsabilidade primária por assistência integral e indenização decorrentes da pesquisa permaneça com o patrocinador, não se onerando o erário, salvo nos casos de pesquisa pública em que o ente seja o patrocinador.

f. Suspender, por arrastamento, os efeitos do art. 5.º da Lei 14.874/2024, no que pressupõe a existência de "instância nacional de ética em

pesquisa" como órgão do Ministério da Saúde, até o julgamento do mérito do vício de iniciativa (arts. 2.º, XXVI, e 8.º).

g. Determinar, liminarmente, ordem estrutural mínima: até o julgamento do mérito e eventual incorporação pela CONITEC/SUS, o patrocinador manterá o fornecimento contínuo do tratamento aos participantes que dele necessitem, sem solução de continuidade, vedadas as hipóteses de interrupção dos incisos IV, V, VI e VII do art. 33, assegurada a transição assistida prevista no art. 35.

2. Quanto ao mérito:

a. A procedência integral da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para:

i. Declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2.º, XXVI, e 8.º da Lei 14.874/2024 por flagrante vício de iniciativa legislativa, violando o disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alíneas "b" e "e", da Constituição Federal.

ii. Declarar a inconstitucionalidade dos arts. 30 a 37 da Lei nº 14.874/2024, por promoverem inaceitável retrocesso a direitos fundamentais sociais, violando o direito fundamental à saúde (art. 6.º e 196 da CF) bem como a vedação ao retrocesso decorrente de tratados internacionais de direitos humanos (Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, Protocolo de San Salvador de 1988; Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos) e da

jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal (ADI 2.065/DF, ARE 727.864/PR)

iii. Subsidiariamente ao item "ii" acima, caso não seja este o entendimento, conferir interpretação conforme a Constituição Federal aos Arts. 30 a 37 da Lei 14.874/2024, para que garantam o acesso gratuito, contínuo e irrestrito ao tratamento pós-estudo para os participantes de pesquisa que dele necessitem, restabelecendo o patamar protetivo anterior e afastando as limitações e critérios de interrupção (em especial os previstos nos incisos IV, V, VI e VII do art. 33) que se revelem incompatíveis com o direito fundamental à saúde.

iv. Declarar a inconstitucionalidade dos arts. 26, § 3.º e 33, inciso VII, da Lei 14.874/2024, por criar ônus financeiro ao Sistema Único de Saúde sem a devida estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro, violando o disposto no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Ou, subsidiariamente, conferir interpretação conforme para que a responsabilidade pelo custeio do tratamento pós-estudo permaneça com o patrocinador da pesquisa, independentemente da disponibilidade do medicamento na rede pública de saúde.

v. Declarar a inconstitucionalidade do art. 7.º, VII, da Lei 14.874/2024, por ser insuficiente para efetivar a diretriz de participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde prevista no Art. 198, inciso III, da Constituição Federal,

bem como declarar a inconstitucionalidade por omissão do art. 8.º da Lei 14.874/2024 pela inexistência de previsão da participação da comunidade na Instância Nacional de Ética em Pesquisa, nos termos estabelecidos pelo art. 198, III, da CF.

vi. Subsidiariamente ao item "v" acima, conferir interpretação conforme para que a participação da comunidade, por meio do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), seja garantida em todos os níveis da governança ética em pesquisa, com caráter deliberativo e abrangente, na formulação, fiscalização e acompanhamento das regras e do próprio desenvolvimento da pesquisa clínica com seres humanos.

vii. Declarar que a Lei 14.874/2024 é incompatível com a racionalidade imposta pelos Temas de Repercussão Geral nº 6 e 1.234, na medida em que suas restrições ao acesso medicamentoso pós-estudo levam à judicialização sem que os pacientes possam obter tutela jurisdicional plena, ante os critérios estabelecidos por esses Temas.

viii. Declarar a inconstitucionalidade do art. 18, § 6.º, da Lei 14.874/2024, por violar a autonomia do paciente e o regime constitucional do consentimento informado (Tema 1.069 da RG; arts. 1.º, III; 5.º, *caput*, II e III; 196 da CF; artigos 5 e 6 da Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos); ou, subsidiariamente, conferir interpretação conforme nos estritos termos definidos na medida cautelar.

ix. Declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 26, § 3.º, da Lei 14.874/2024, para excluir qualquer interpretação que transfira ao SUS ou a instituições públicas não patrocinadoras a responsabilidade financeira por assistência integral/indenizações decorrentes da pesquisa sem a prévia estimativa de impacto orçamentário (art. 113 do ADCT) e sem vínculo de patrocinador público; ou, subsidiariamente, conferir interpretação conforme para fixar a responsabilidade primária do patrocinador, preservando-se o erário.

x. Declarar a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5.º da Lei 14.874/2024, no que supõe a criação da "instância nacional de ética em pesquisa" como órgão integrante do Ministério da Saúde, em decorrência do vício de iniciativa reconhecido quanto aos arts. 2.º, XXVI, e 8.º.

xi. Fixar interpretação conforme aos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral, assentando que até a decisão de incorporação e efetiva disponibilização no SUS, o patrocinador permanece responsável pelo fornecimento do tratamento aos participantes que dele necessitem, vedadas interrupções baseadas nos incisos IV, V, VI e VII do art. 33, sob pena de afronta ao direito fundamental à saúde e de estímulo indevido à judicialização.

b. A fixação de tese de julgamento (efeito vinculante) que reafirme:

i. A essencialidade da observância das regras constitucionais de processo legislativo, em especial a iniciativa privativa do Poder Executivo em matéria de organização administrativa.

ii. A vedação ao retrocesso de direitos fundamentais sociais, como o direito à saúde e ao controle social, implicando a impossibilidade de redução do patamar de proteção já alcançado na regulação de pesquisa clínica.

iii. A indispensabilidade da participação da comunidade (controle social) em todas as esferas de deliberação e fiscalização do Sistema Único de Saúde, incluindo a governança ética em pesquisa, conforme Art. 198, III, da CF.

iv. A necessidade de respeito ao art. 113 do ADCT, que exige estimativa de impacto orçamentário e financeiro para proposições legislativas que criem ou alterem despesas obrigatórias.

v. A centralidade da autonomia e do consentimento informado também em pesquisa em emergência, vedada inclusão sem consentimento prévio salvo requisitos estritos de impossibilidade material, risco imediato, salvaguardas reforçadas e consentimento substituto/diferido (compatibilização com o Tema 1.069).

vi. A responsabilidade primária do patrocinador por assistência integral e continuidade terapêutica pós-estudo até a efetiva incorporação e disponibilização no SUS, como corolário do

direito à saúde, da vedação ao retrocesso e da coerência com os Temas 6 e 1.234, sem transferência automática de custos ao erário (art. 113 do ADCT).

vii. Invalidade, por vício de iniciativa, de criação de órgãos na estrutura do Poder Executivo por lei de iniciativa parlamentar, com declaração por arrastamento dos dispositivos que pressuponham a existência do órgão.

c. Caso Vossa Excelência entenda necessário, a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, a fim de evitar vácuo regulatório, preservando as salvaguardas dos direitos fundamentais e estabelecendo prazo razoável para a adequação das normas e práticas.

d. A intimação dos órgãos e entidades interessados, nos termos da Lei 9.868/1999, bem como a oitiva da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, conforme preceituado no art. 103, § 3.º, da Constituição Federal.

e. A prioridade de inclusão na pauta de julgamento do Plenário deste E. STF, observando-se o art. 145, VIII, do Regimento Interno do STF.

f. Requer-se designação e a realização de audiência pública, nos termos do art. 9.º, § 1.º, da Lei 9.868/1999, em data próxima, para colher subsídios técnicos e científicos sobre os impactos constitucionais, sanitários e orçamentários da Lei 14.874/2024, em especial quanto à

(i) criação de órgão na estrutura do Ministério da Saúde por iniciativa parlamentar;

(ii) regime de acesso pós-estudo e suas hipóteses de interrupção;

(iii) autonomia e consentimento em pesquisa em emergências; e

(iv) desenho de participação social (art. 198, III, CF).

Sugere-se a oitiva, entre outros, de: Conselho Nacional de Saúde (CNS); Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP); Anvisa; Conitec; Fiocruz; SBPC; Abrasco; sociedades científicas pertinentes; Sociedade Brasileira de Bioética (SBB); entidades representativas de pacientes (doenças raras e crônicas); universidades e centros de pesquisa com CEP ativo; e associações de patrocinadores e organizações de pesquisa clínica (CROs).

g. Requer-se a habilitação, como *amici curiae*, nos termos do art. 7.º, § 2.º, da Lei 9.868/1999, das instituições e entidades acima indicadas, bem como de outras que o Relator entender pertinentes, facultando-lhes a juntada de memoriais e a realização de sustentações orais, dada a alta complexidade técnica e a repercussão geral das matérias em exame (direito à saúde, controle social, processo legislativo, avaliação de tecnologias em saúde e ética em pesquisa).

h. Requer-se, ainda, a distribuição por conexão desta Ação Direta de Inconstitucionalidade aos Temas de Repercussão Geral n.º 6 e n.º 1.234, uma vez que a Lei 14.874/2024, ao dispor sobre o acesso pós-estudo e criar restrições à continuidade do tratamento, impacta diretamente a racionalidade e o alcance dos parâmetros estabelecidos por esta Corte para a judicialização da saúde, notadamente no que concerne ao fornecimento de medicamentos não incorporados,

sendo imprescindível a análise conjunta para a garantia da coerência jurisdicional e da segurança jurídica na matéria, do mesmo modo como também impacta na tese estabelecida pelo Tema de Repercussão Geral n.º 1.069, todos da mesma relatoria.

Por fim, requer-se que das intimações oficiais pela imprensa conste exclusivamente o nome do Dr. **Henderson Fürst, OAB/SP n. 310.855**, com escritório na SHS Quadra 6, Conjunto A, Bloco E, sala 227, Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70316-902, sob pena de nulidade.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 16 de setembro de 2025

ELDA BUSSINGUER

Presidente da Sociedade Brasileira de Bioética

HENDERSON FÜRST

OAB/SP 310.855

GABRIELLE BEZERRA SALES

OAB/CE 8.139

CARLOS FERNANDO POLTRONIERI PRATA

OAB/ES 28.637

ARTHUR HENRIQUE DE PONTES REGIS

OAB/DF 27.251

ICP Brasil
Documento assinado digitalmente
HENDERSON FIIRST DE OLIVEIRA
Data: 16/09/2025 16:00:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br